УГАДАЙ СНИМОК · МОДУЛЬ 1 ИЗ 4

УЗИ матки: норма, пороки, миометрий

8 эхограмм. Посмотрите на снимок, прочитайте короткую вводную и выберите один из четырёх вариантов. Ответ и разбор — на следующем слайде.

01

На ответ — 30 секунд. Варианты называет вслух вся группа.

02

Назовите не только диагноз, но и признак, по которому вы его поставили.

03

Балл за верный ответ, ещё балл — за названный признак.

Жумагулов Н.М. · АДЦ «Сономедплюс», г. Ош · Первичная специализация по УЗ-диагностике

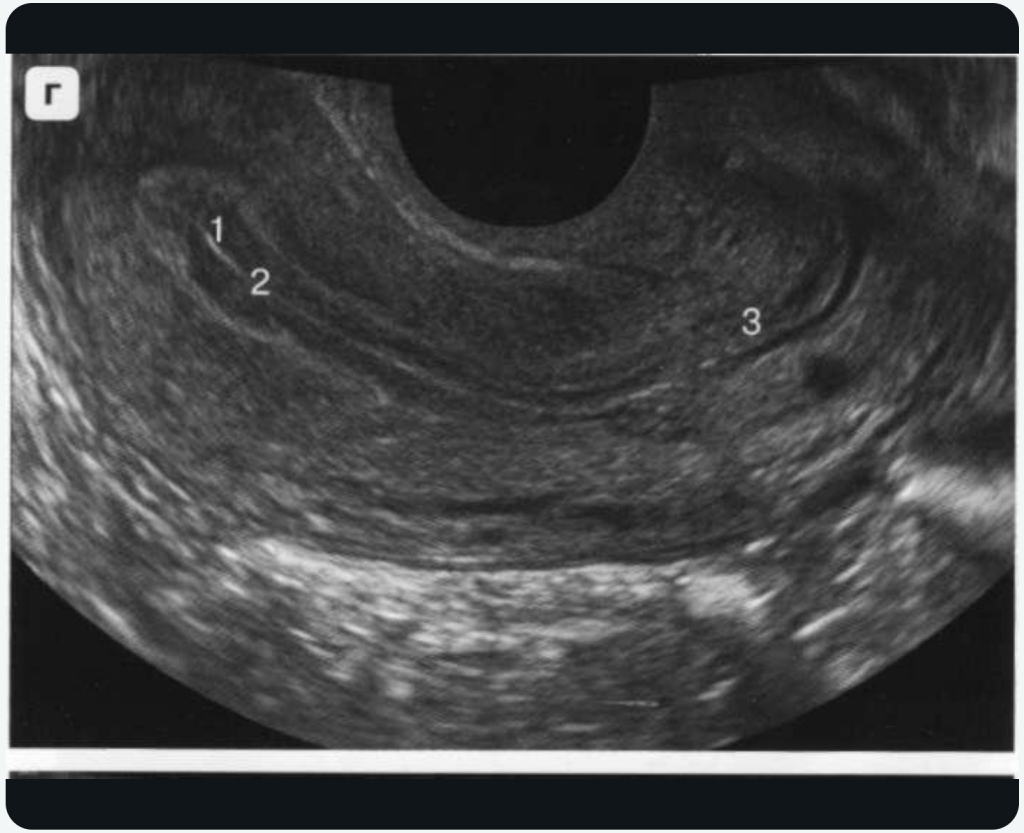


Снимок 1 / 8

28 лет, 13-й день цикла. ТВУЗИ, продольный срез матки.

Как оценить эндометрий (2)?

- **А** Секреторный
- **Б** Трёхслойный, норма
- **В** Гиперплазия
- **Г** Полип эндометрия



Ответ · Б

Норма: трёхслойный эндометрий поздней пролиферации

- Две наружные гиперэхогенные линии, гипоэхогенный функциональный слой и срединное эхо.
- Толщина в 11–14-й день — 7–14 мм, в среднем 11 мм.
- Цервикальный канал (3) расширен за счёт слизистой пробки.

Вывод: толщину эндометрия без дня цикла не интерпретируют. Те же 12 мм на 5-й день — повод к дообследованию.

Источник: Буланов М.Н. Ультразвуковая гинекология, т. 1, рис. 2.27 г · 1 — матка, 2 — эндометрий, 3 — канал шейки

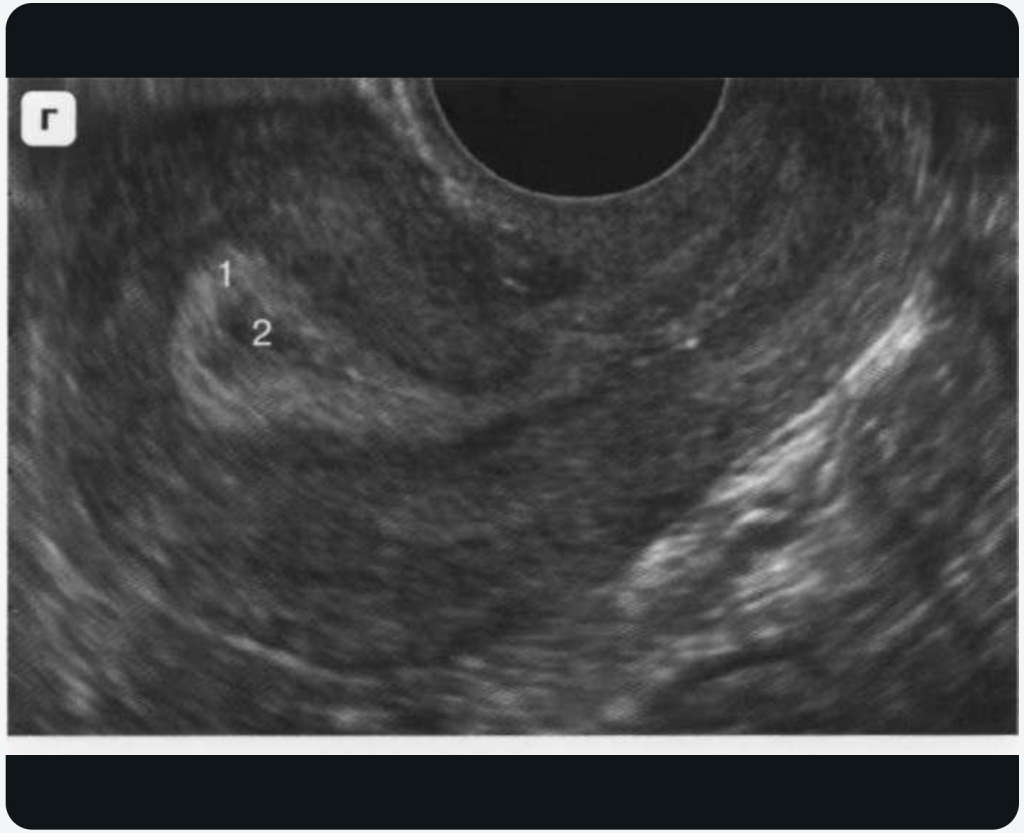


Снимок 2 / 8

30 лет, 21-й день цикла, жалоб нет. ТВУЗИ, продольный срез.

Как оценить эндометрий?

- **А** Трёхслойный
- **Б** Секреторный, норма
- **В** Рак эндометрия
- **Г** Гематометра



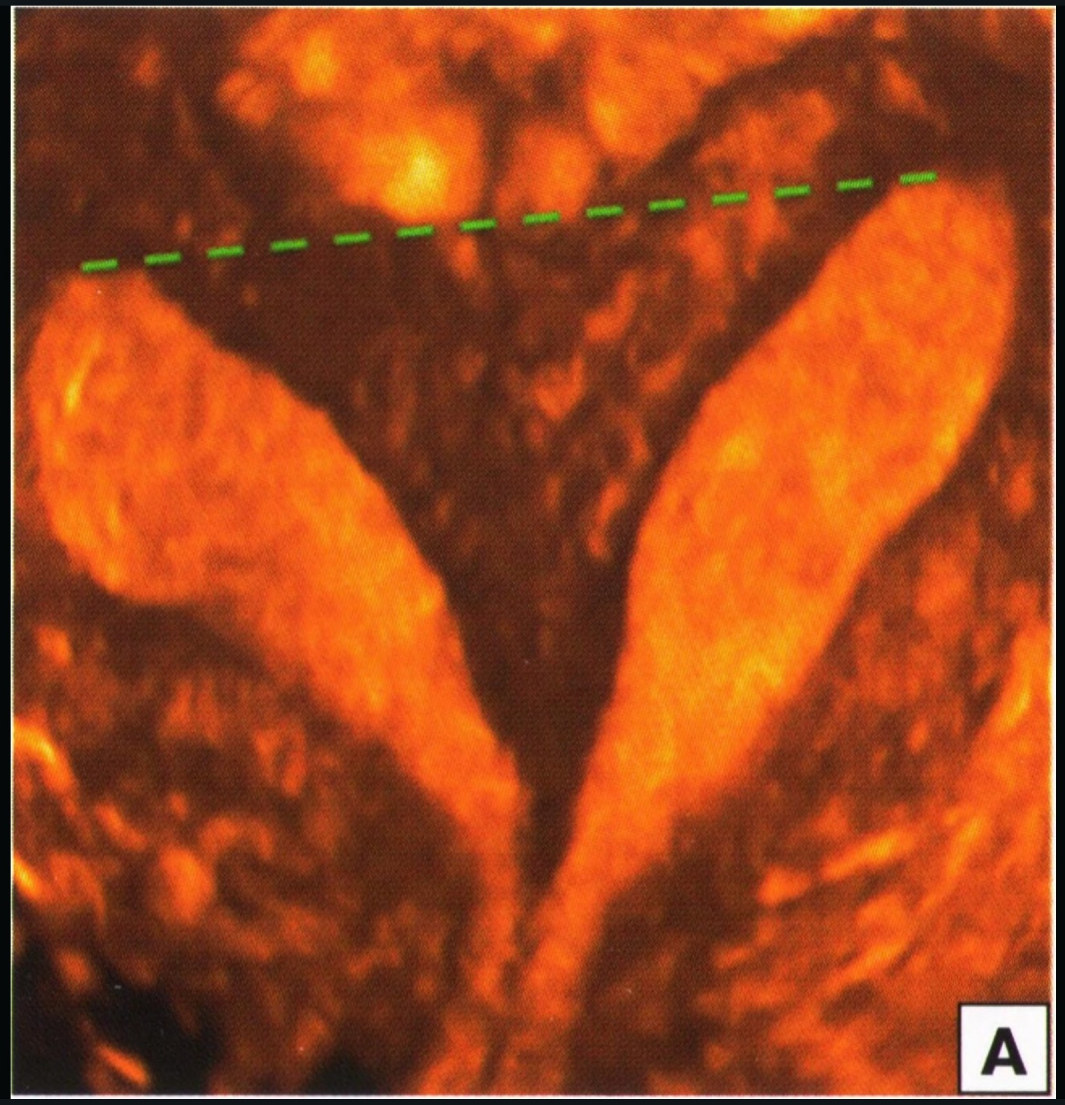
Ответ · Б

Норма: эндометрий середины секреторной фазы

- Гиперэхогенная зона (1) занимает почти всю толщу эндометрия.
- Центральные отделы (2) остаются гипоэхогенными, линия смыкания не видна.
- Толщина в 19–23-й день — 10–16 мм, в среднем 14 мм.

Вывод: в секреторную фазу полип и гиперплазия неотличимы от нормы. Ищите их на 5–7-й день цикла.

Источник: Буланов М.Н. Ультразвуковая гинекология, т. 1, рис. 2.29 г

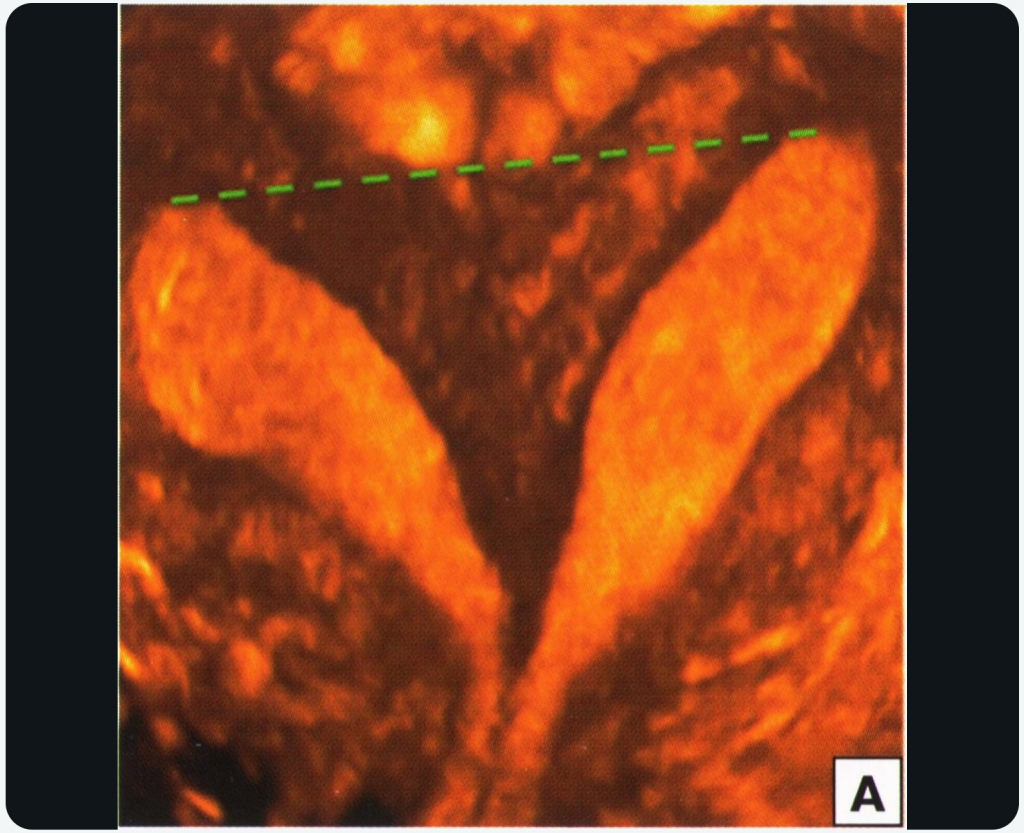


Снимок 3 / 8

Бесплодие. Коронарный срез матки, 3D-реконструкция.

Какой порок развития?

- **А** Перегородчатая матка
- **Б** Двурогая матка
- **В** Седловидная матка
- **Г** Однорогая матка



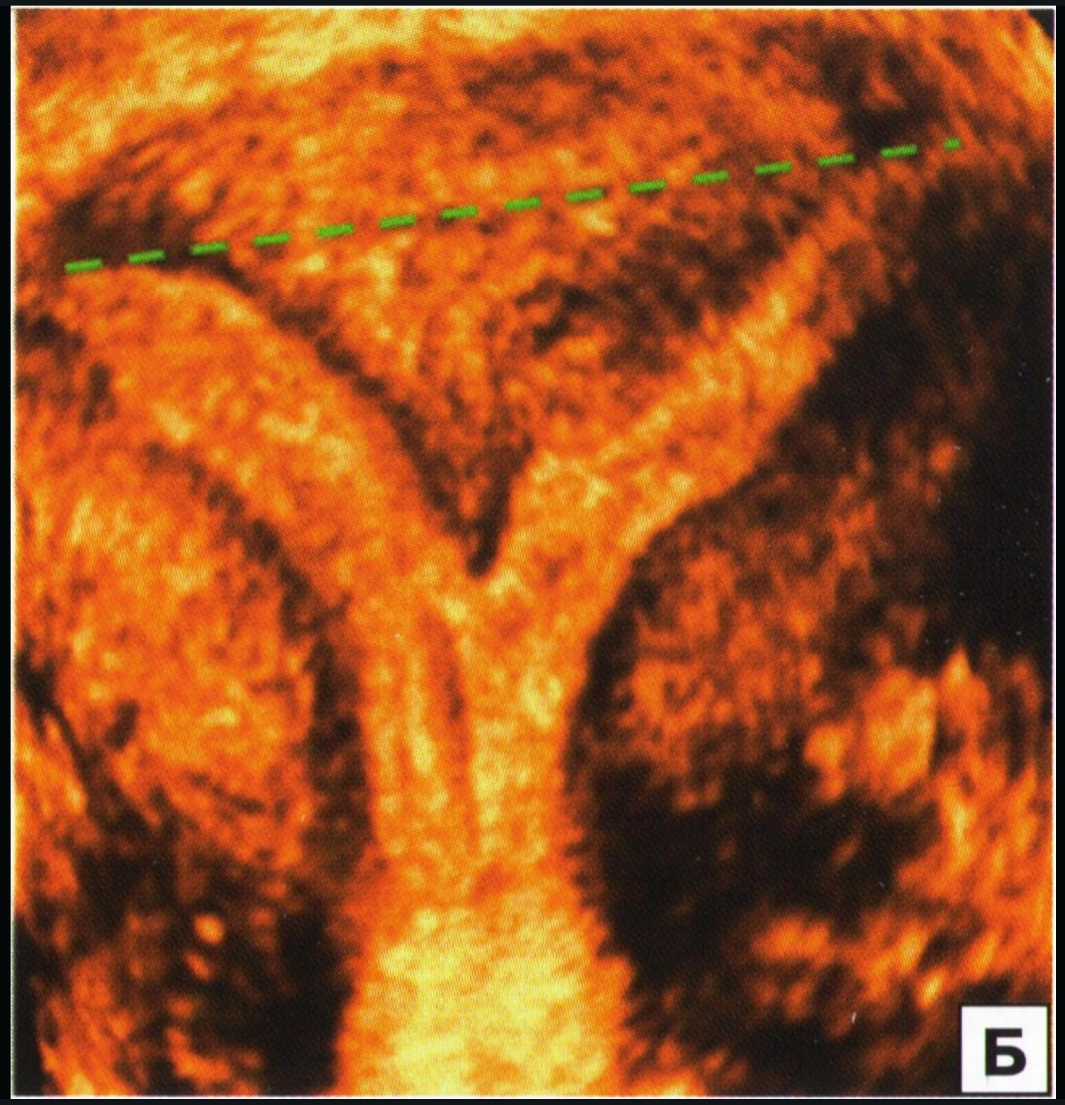
Ответ · Б

Двурогая (двутелая) матка, ESHRE/ESGE U3

- Наружный контур дна глубоко вдавлен: вырезка более 50% толщины стенки матки.
- Два рога расходятся, между ними — миометрий.
- Дно уходит ниже межтрубной линии (пунктир).

Вывод: двурогую от перегородчатой отличает наружный контур дна, а не форма полости. Нужен коронарный срез.

Источник: Медведев М.В. и соавт. Ультразвуковая диагностика в гинекологии, рис. 5.37 А

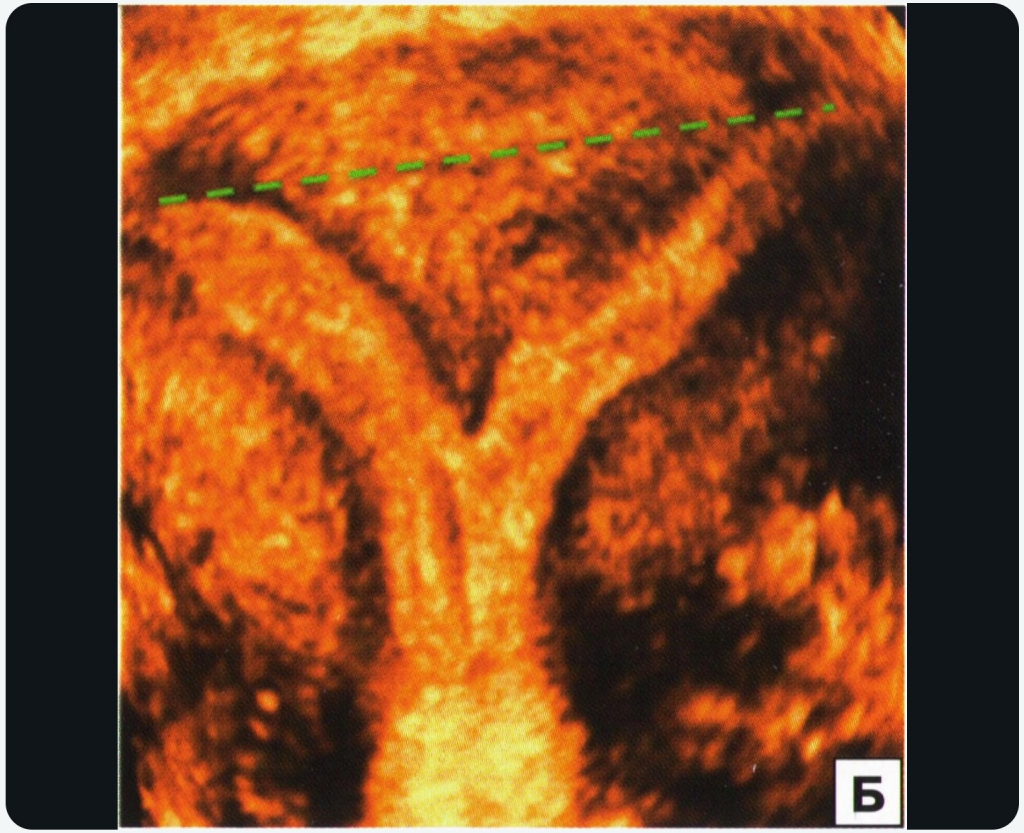


Снимок 4 / 8

Два выкидыша в I триместре. Коронарный срез, 3D.

Какой порок развития?

- **А** Перегородчатая матка
- **Б** Двурогая матка
- **В** Седловидная матка
- **Г** Нормальная матка



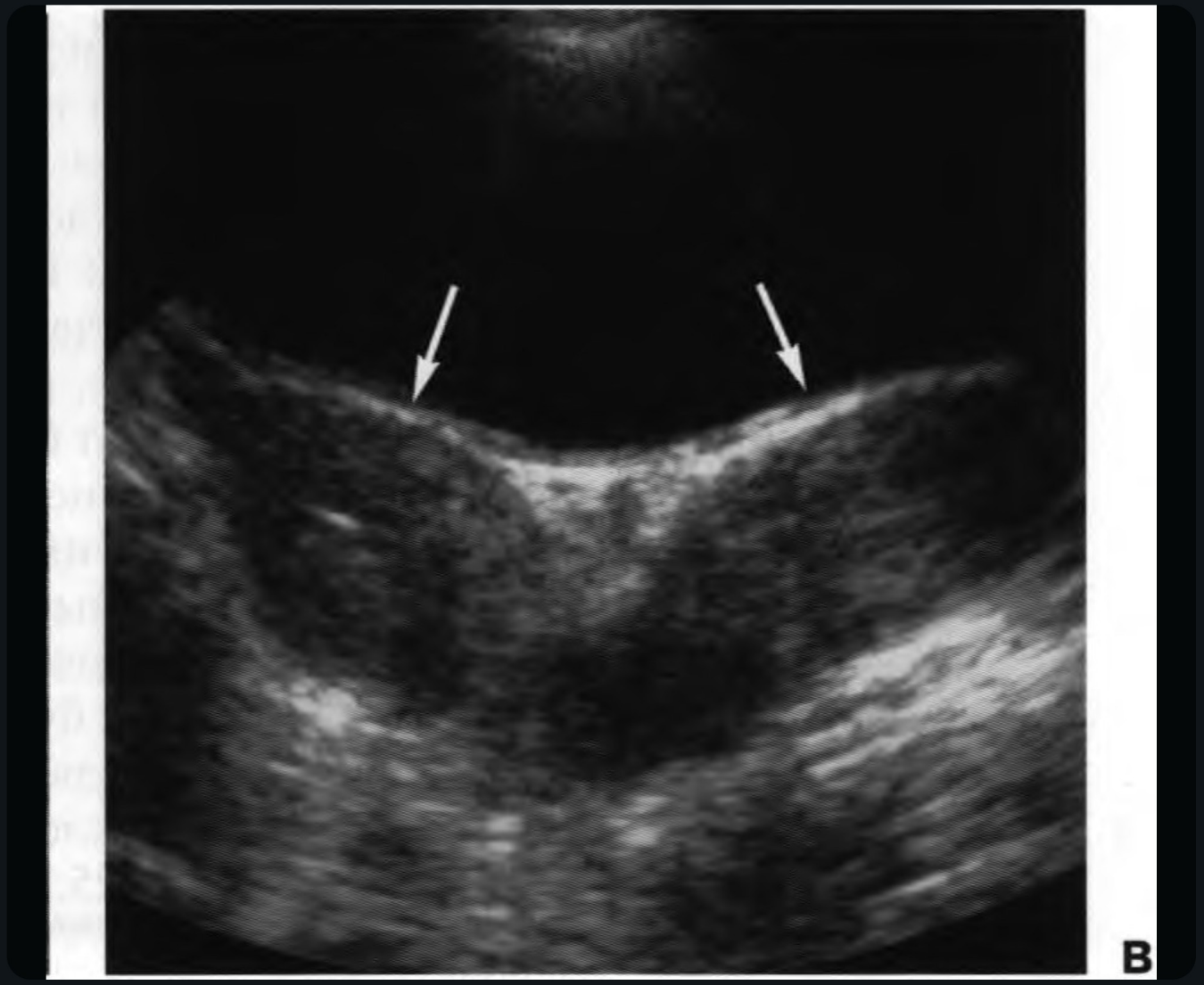
Ответ · А

Перегородчатая матка с широкой перегородкой, U2

- Наружный контур дна ровный, лежит на межтрубной линии.
- Внутреннее вдавление в полость — более 50% толщины стенки матки.
- Полость разделена широкой перегородкой на две половины.

Вывод: перегородку рассекают гистероскопически, двурогую матку так не лечат. Ошибка в классификации меняет тактику.

Источник: Медведев М.В. и соавт. Ультразвуковая диагностика в гинекологии, рис. 5.37 Б

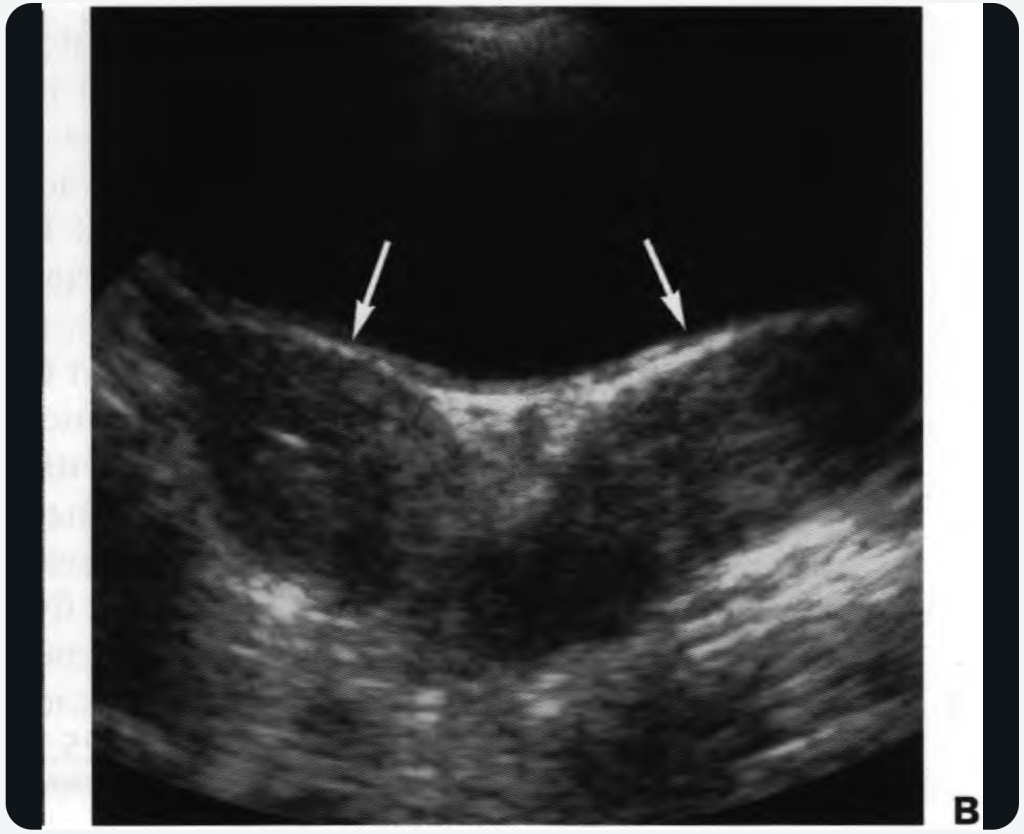


Снимок 5 / 8

Поперечный срез тела и дна. На срезе шейки видны два раздельных цервикальных канала.

Ваше заключение?

- **А** Седловидная матка
- **Б** Перегородчатая матка
- **В** Полное удвоение матки
- **Г** Две субсерозные миомы



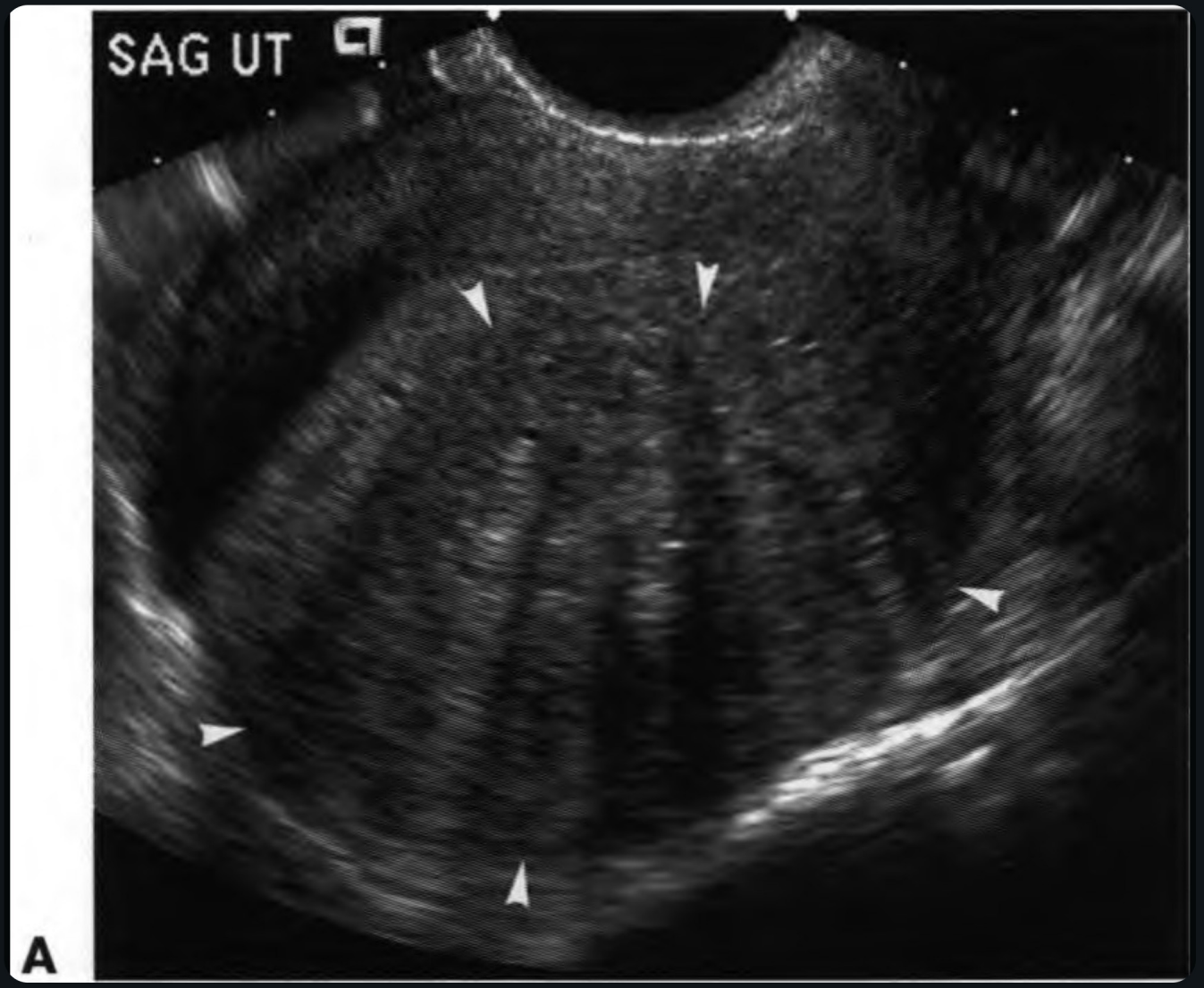
Ответ · B

Полное удвоение матки (U3 + C2 по ESHRE/ESGE)

- Левый и правый рога раздельны от средней части тела до дна (стрелки).
- Две шейки с двумя цервикальными каналами.
- Каждая половина имеет свою полость и эндометрий.

Вывод: при любом пороке развития матки осмотрите почки: удвоение нередко сочетается с агенезией почки на одной стороне.

Источник: Дубиле П.М., Бенсон К.Б. Атлас по УЗД в акушерстве и гинекологии, рис. 25.3-2 B, 25.3-4

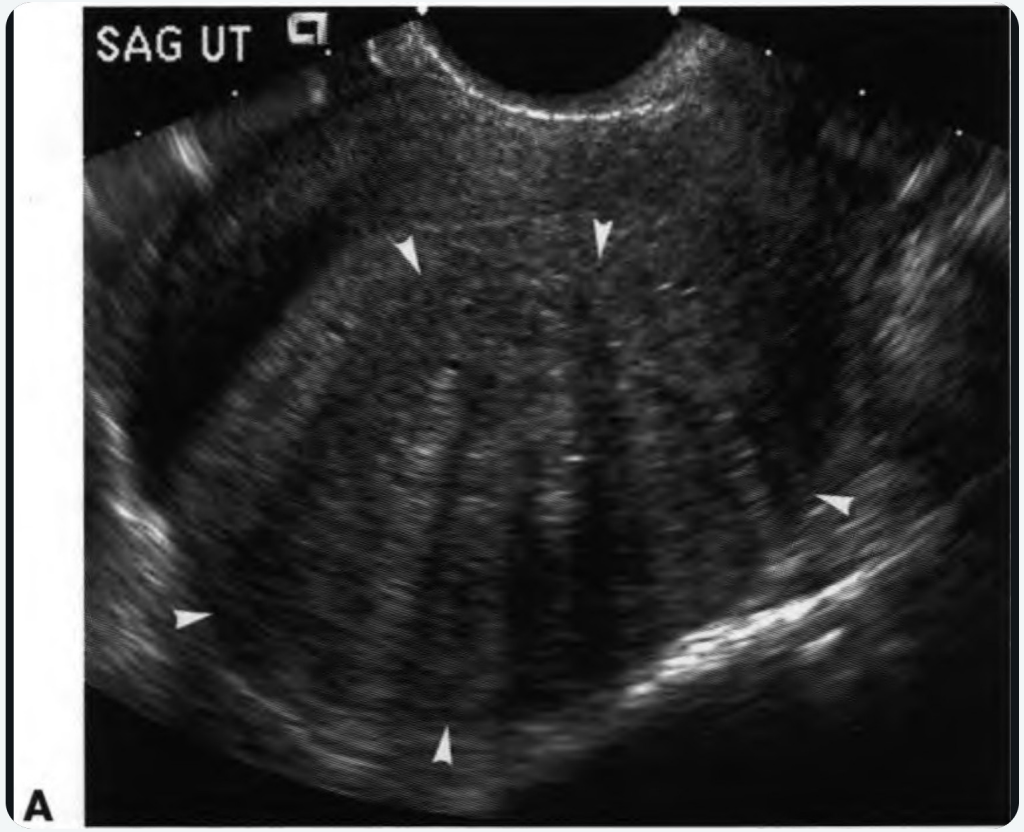


Снимок 6 / 8

41 год, обильные и болезненные менструации. Матка шаровидная. Продольный срез.

Ваше заключение?

- **А** Интрамуральная миома
- **Б** Аденомиоз
- **В** Саркома матки
- **Г** Артефакт от кишечника



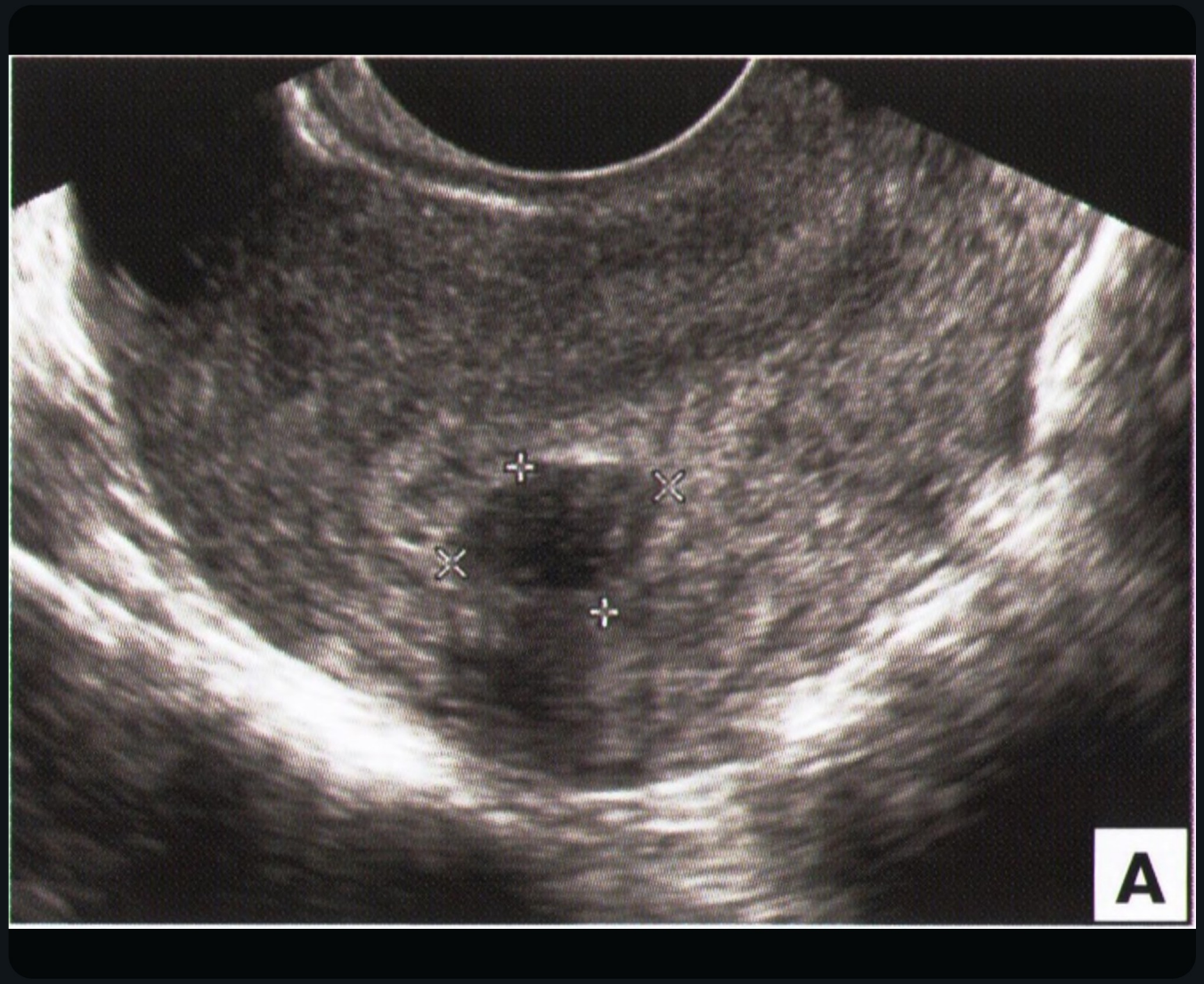
Ответ · Б

Аденомиоз

- Веерообразные тени («жалюзи») из миометрия, без чёткого узла.
- Утолщённая неоднородная стенка, нечёткая граница с эндометрием.
- По MUSA это косвенные признаки; прямые — кисты миометрия, гиперэхогенные островки, эхогенные субэндометриальные линии.

Вывод: у миомы тени краевые, от капсулы, а кровоток огибает узел. У аденомиоза тени веерные, сосуды проходят сквозь очаг.

Источник: Дубиле П.М., Бенсон К.Б. Атлас по УЗД в акушерстве и гинекологии, рис. 25.2-1 А

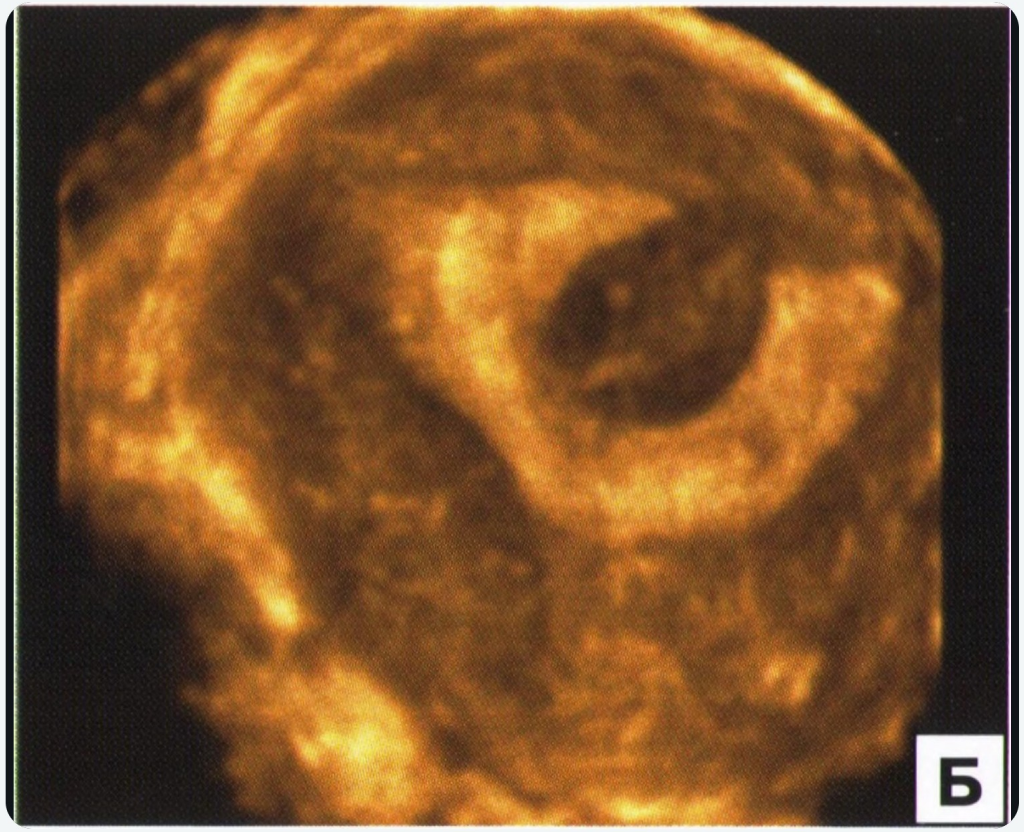


Снимок 7 / 8

38 лет, меноррагия. Продольный срез, образование между метками.

Что в полости матки?

- **А** Полип эндометрия
- **Б** Субмукозная миома
- **В** Сгусток крови
- **Г** Аденомиома



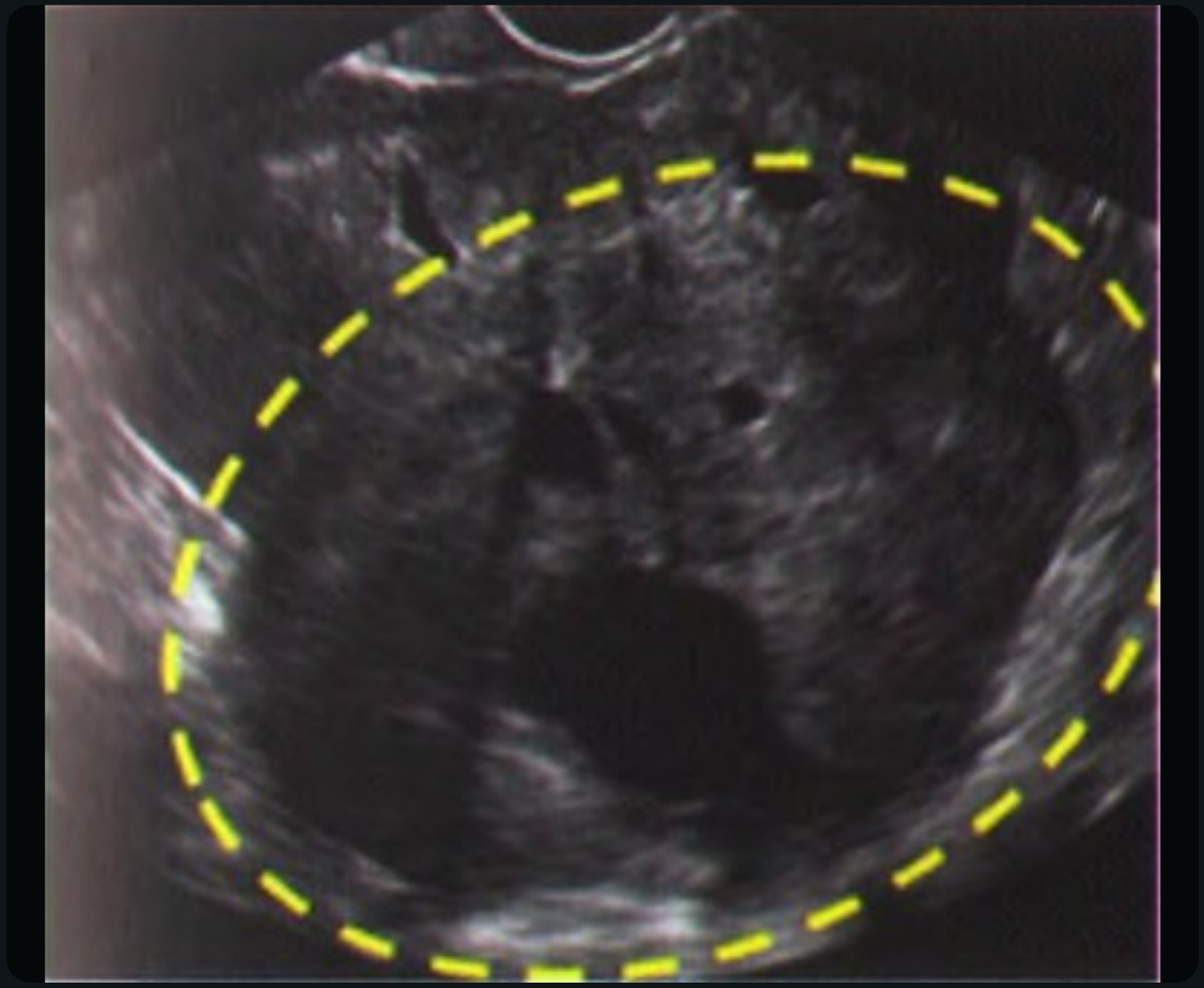
Ответ · Б

Субмукозный миоматозный узел, FIGO тип 1

- Округлое гипоэхогенное образование, деформирующее полость.
- Исходит из миометрия; интрамуральная часть узла меньше 50%.
- На 3D-реконструкции полости (снимок слева) узел выбухает в полость.

Вывод: полип обычно вытянутый, гиперэхогенный, с одной питающей ножкой. Миома круглая, с циркулярным кровотоком. Сгусток аваскулярен.

Источник: Медведев М.В. и соавт. Ультразвуковая диагностика в гинекологии, рис. 5.56 А, Б

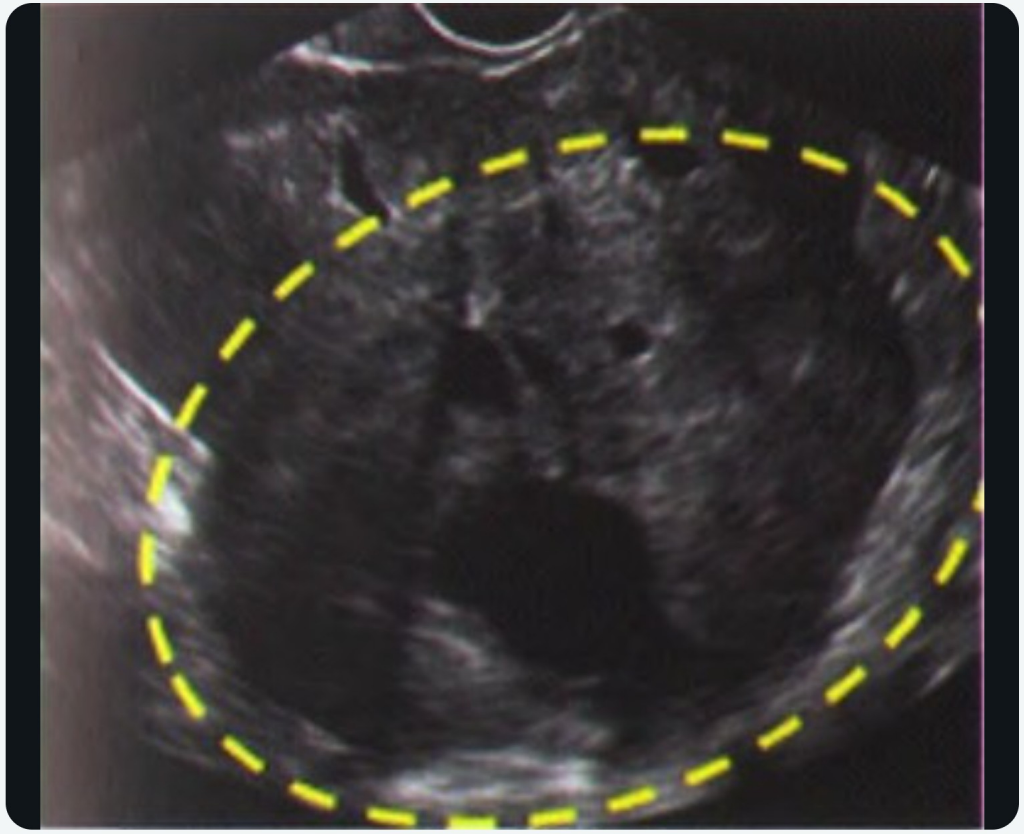


Снимок 8 / 8

44 года. Узел в матке известен 3 года, сейчас изменилась структура. Образование обведено.

Ваше заключение?

- **А** Аденомиоз
- **Б** Миома с дегенерацией
- **В** Эндометриома
- **Г** Гематометра



Ответ · Б

Миома с дегенеративными изменениями

- Узел с чётким контуром, смещающий окружающий миометрий.
- Неоднородная структура с анэхогенными полостями внутри узла.
- Дегенерация бывает гиалиновой, кистозной, красной (при беременности), с обызвествлением.

Вывод: быстрый рост, особенно в постменопаузе, нечёткие контуры и хаотичный внутренний кровоток требуют исключить саркому. УЗИ её не исключает.

Источник: Медведев М.В. и соавт. Ультразвуковая диагностика в гинекологии, рис. 1.27

Ответы модуля 1

№	Диагноз	Ключевой признак
1	Трёхслойный эндометрий, норма	Три линии в 11–14-й день
2	Секреторный эндометрий, норма	Гиперэхогенный, без срединной линии
3	Двурогая матка, U3	Вырезка наружного контура дна
4	Перегородчатая матка, U2	Ровный наружный контур, вдавление изнутри
5	Полное удвоение матки	Два тела и две шейки
6	Аденомиоз	Веерообразные тени без узла
7	Субмукозная миома FIGO 1	Круглый узел, деформирующий полость
8	Миома с дегенерацией	Чёткий контур, кисты внутри узла

Эхограммы: Буланов М.Н. Ультразвуковая гинекология, т. 1 (2010); Медведев М.В., Алтынник Н.А., Шатоха Ю.В. Ультразвуковая диагностика в гинекологии (2018); Дубиле П.М., Бенсон К.Б. Атлас по УЗД в акушерстве и гинекологии (2011). Только для учебных занятий группы; для публикации нужно согласие правообладателей.